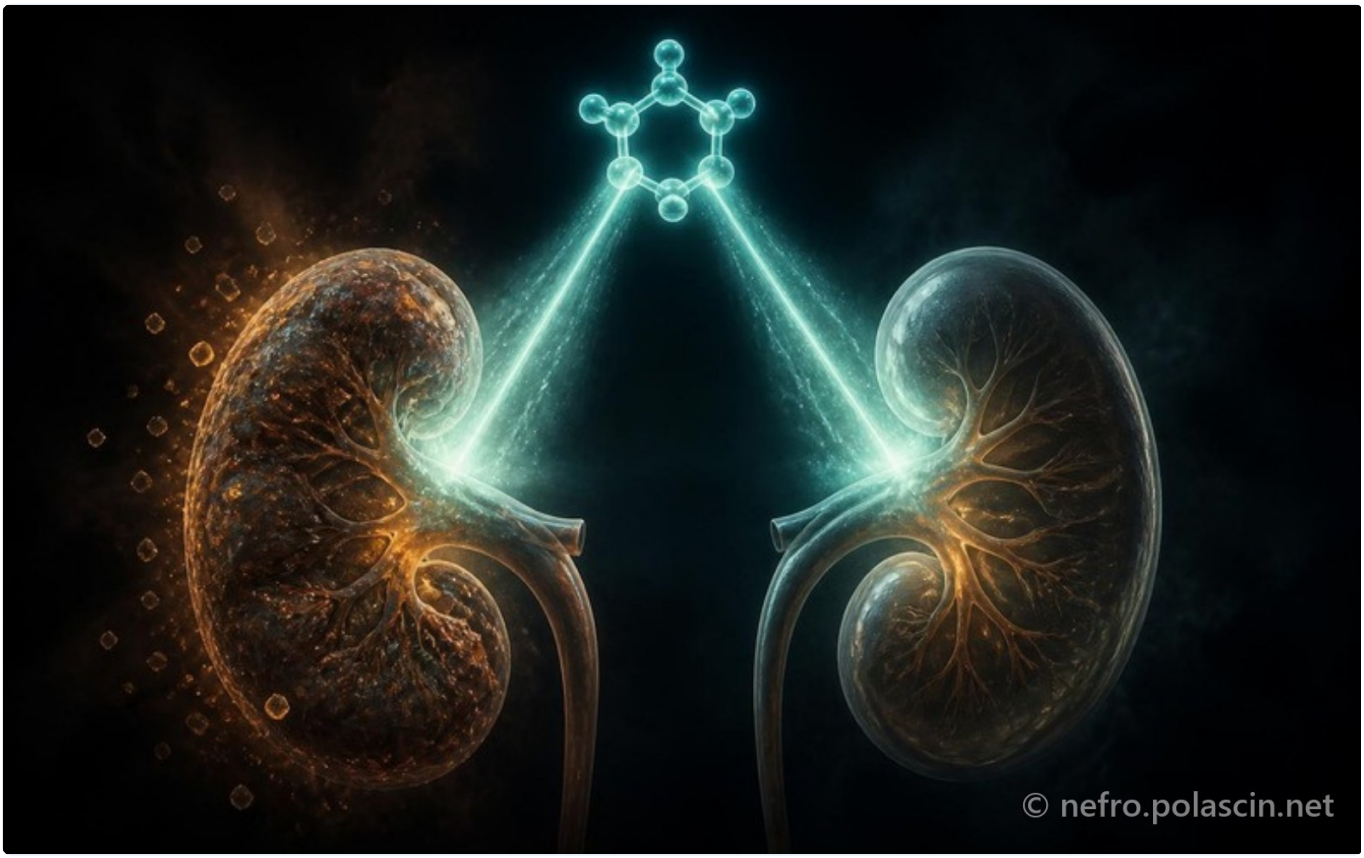
Finerenón: nefroprotektívny účinok aj pri CKD 3–4 bez ohľadu na diabetes

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín · Publikované: 16.06.2026



Poloschematická vizualizácia. Ochrana obličky nezávisí od prítomnosti diabetu – to je jadro nálezu.

Portál Physicians Weekly opisuje výsledky štúdie, v ktorej **finerenón** dokázal **spomaliť progresiu chronickej choroby obličiek (CKD)** u pacientov v **3.–4. štádiu** s **eGFR 20 až 60 ml/min** a **stredne ťažkou až ťažkou albuminúriou**, a to **nezávisle od prítomnosti diabetu**. Text zdôrazňuje aj bezpečnosť: nárast **hyperkaliémie** sa nepozoroval.

Kto bol v štúdii

Išlo o prospektívne hodnotenie u **180 ambulantných pacientov** v Iraku (CKD 3.–4. štádia; eGFR **20–60 ml/min**; **UACR > 30 mg/g**):

- pri vstupnom hodnotení malo **78 % pacientov diabetes**,
- **36 %** malo eGFR v pásme **20 až 25 ml/min**.

Hlavné výsledky (po 1 roku)

V skupine ako celku:

- **eGFR sa zlepšila**: z približne **32 ± 10** na **47 ± 15 ml/min**,
- **UACR sa znížila**: z približne **542 ± 400** na **180 ± 170 mg/g**.

Analýza podskupín

Pacienti bez diabetu

- eGFR: z približne **33 ± 10** na **50 ± 16 ml/min**,

- UACR: z približne **592 ± 431** na **203 ± 197 mg/g**.

Pacienti s eGFR 20 až 25 ml/min

- eGFR: z približne **21 ± 2** na **36 ± 8 ml/min** po roku,
- UACR: z približne **602 ± 380** na **209 ± 152 mg/g**.

Bezpečnosť: draslík

Článok priamo uvádza, že **finerenón nezvyšoval hladinu sérového draslíka**. Aj v podskupine s eGFR **20–25 ml/min** boli priemerné hodnoty draslíka približne **4,8 ± 0,7 mmol/l na začiatku** a **4,8 ± 0,6 mmol/l po 1 roku**.

Praktické ponaučenie

Zdroj podporuje predstavu, že u vybraných pacientov s **CKD 3.–4. štádia a významnou albuminúriou** môže mať finerenón **nefroprotektívny prínos aj bez diabetu**. Ide však o reálnu populáciu (ambulantní pacienti, podľa textu zjavne mimo schválenej indikácie), z čoho pre prax vyplýva:

- do úvahy prichádzajú pacienti s albuminúriou (UACR > 30 mg/g) a eGFR v príslušnom rozmedzí,
- draslík treba monitorovať podľa bežných klinických zásad, aj keď v tejto kohorte hyperkaliémia nebola problémom.

Dôležitá opatrnosť pri interpretácii

Text je správou o štúdii a neuvádza všetky detaily (dizajn, presné parametre a štatistické testy). Pozoruhodné je najmä *zlepšenie* eGFR, ktoré je pri tejto liekovej triede netypické a samo osebe si vyžaduje opatrnú interpretáciu. Závery preto treba brať ako **signál** a smer – pre prax sú zaujímavé, ale pred nasadením u konkrétneho pacienta treba dodržať lokálne odporúčania a bezpečnostné monitorovanie.

Zdroj: *Physicians Weekly: „Finerenone Effective for Stage 3-4 Kidney Disease Regardless of Diabetes Status“. Link na zdroj.*

Zdroj: https://nefro.polascin.net/article.php?slug=finerenon-nefroprotekcia-ckd-3-4-bez-ohladu-na-diabetes · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.